

© Коллектив авторов, 2026

УДК 614+316.622

Поведенческие модели заботы о психическом здоровье жителей крупных городов России

С.А. Судьин, Т.В. Носкова, А.О. Барг

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
ул. Букирева, д. 15, г. Пермь, Пермский край, 614990, Российская Федерация

Резюме

Введение. Психическое здоровье остается одним из приоритетов глобальной и национальной политики здравоохранения. Городская среда выступает самостоятельным фактором риска, повышая распространенность психических расстройств и уязвимость жителей к тревоге. Несмотря на изученность отдельных практик, в российских исследованиях они не концептуализированы как целостные и устойчивые поведенческие модели.

Цель исследования: выявить и описать поведенческие модели заботы о психическом здоровье среди жителей крупных городов России.

Материалы и методы. Исследование выполнено в логике микс-методологии (объяснительный последовательный дизайн). На качественном этапе с жителями Перми, Новосибирска и Нижнего Новгорода проведены полуструктурированные интервью ($n = 69$, 2023–2024 гг.), на основе которых построена типология из трех моделей заботы о психическом здоровье – активной, пассивной и игнорирующей. На количественном этапе проведен формализованный онлайн-опрос жителей тех же городов ($n = 2073$, март–апрель 2025 г.), в ходе которого типология была расширена до четырех моделей за счет добавления ситуативной.

Результаты. Более трети опрошенных часто или очень часто испытывают сильный стресс. Основным ресурсом совладания является неформальная поддержка близких, тогда как к профессиональной помощи обращается небольшая (менее 5 %) доля респондентов. Ведущей моделью заботы о психическом здоровье выступает ситуативная модель (характерна для 43,5 % опрошенных), ядра активной и пассивной моделей сопоставимы по размеру, игнорирующая модель наименее распространена. Социально-демографические характеристики слабо предсказывают принадлежность к модели, за исключением игнорирующей, наиболее характерной для мужчин старшего возраста с более высоким доходом и более низким образованием.

Заключение. Обоснована и валидирована четырехчастная типология поведенческих моделей заботы о психическом здоровье жителей крупных российских городов. Наиболее проблемной является игнорирующая модель, носители которой систематически отрицают наличие стресса и практически не обращаются за профессиональной помощью, что требует целенаправленной работы с установками горожан.

Ключевые слова: психическое здоровье; городское население; психологический стресс; самосохранительное поведение; забота о здоровье.

Для цитирования: Судьин С.А., Носкова Т.В., Барг А.О. Поведенческие модели заботы о психическом здоровье жителей крупных городов России // Здоровье населения и среда обитания. 2026. Т. 34. № 9. С. 18–28. doi: 10.35627/2219-5238/2026-34-9-18-28

Mental Health Help-Seeking Behaviors among Residents of Major Russian Cities

Sergei A. Sudin, Tatyana V. Noskova, Anastasiya O. Barg

Perm State National Research University, 15 Bukirev Street, Perm, 614990, Russian Federation

Summary

Introduction: Mental health remains a priority in global and national health policies. The urban environment is an independent risk factor that increases the prevalence of mental disorders and vulnerability of citizens to anxiety. Russian studies to date have not identified specific stress-coping practices as distinct behavioral patterns.

Objective: To identify and describe behavioral patterns of mental health help-seeking among residents of major Russian cities.

Materials and Methods: The study was conducted using a mixed-methods approach. During the qualitative phase, semi-structured interviews were conducted with residents of Perm, Novosibirsk, and Nizhny Novgorod ($n = 69$, 2023–2024), based on which a typology of three mental health care models was developed: active, passive, and neglectful. During the quantitative phase (March–April 2025), a standardized online survey was conducted among residents of the same cities ($n = 2,073$), and the typology was expanded to four models by adding a situational (context-dependent) one.

Results: More than one-third of the respondents experience severe stress frequently or very frequently, with informal support from loved ones remaining the primary coping resource, while only a small proportion of respondents (< 5 %) seek professional help. The situational model proved to be the most prevalent (43.5 %); the cores of active and passive models were comparable in size, while the neglectful model was the least common. Sociodemographic characteristics were poor predictors of model affiliation, with the exception of the neglectful model, which was most often noted in older men with higher levels of income but lower levels of education.

Conclusions: A four-part typology of behavioral models of mental health care among residents of large Russian cities has been established and validated. The neglectful model is of concern as its adherents keep denying stress and fail to seek professional help, which requires targeted interventions to address the attitudes of citizens.

Keywords: mental health, urban population, psychological stress, help-seeking behavior, health behavior.

Cite as: Sudin SA, Noskova TV, Barg AO. Mental health help-seeking behaviors among residents of major Russian cities. *Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya*. 2026;34(9):18–28. (In Russ.) doi: 10.35627/2219-5238/2026-34-9-18-28

Введение. Психическое здоровье населения последовательно закрепляется в качестве приоритета глобальной политики здравоохранения. В мае 2013 г. на 66-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был принят Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013–2020 гг. В 2019 г. его действие продлили до 2030 г., связав с целью устойчивого развития ООН 3.4 – сократить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний за счет укрепления психического здоровья¹. По оценкам исследования глобального бремени болезней, уже в 2019 г., до начала пандемии COVID-19, депрессия занимала второе место среди причин потери трудоспособности в мире, а тревожные расстройства – восьмое [1]. Тревожные расстройства при этом остаются наиболее распространенными видами психических нарушений².

На национальном уровне охрана психического здоровья населения тесно связана с задачами управления общественным здоровьем в Российской Федерации. Так, Указ Президента РФ от 8 декабря 2025 г. № 896 «О Стратегии развития здравоохранения... до 2030 года» предусматривает расширение сети кабинетов психологической помощи женщинам и утверждает психологическую реабилитацию как неотъемлемую часть медицинской, окончательно интегрируя эту сферу в систему здравоохранения³.

Помимо рамочной трактовки психического здоровья Всемирной организации здравоохранения (состояние благополучия, при котором человек способен эффективно справляться со стрессами, реализовывать свои способности, продуктивно учиться и работать⁴), скорее задающей вектор социальной политики, в науке сложилось несколько теоретических подходов. Интегративный подход рассматривает психическое здоровье в неразрывной связи с категорией общего благополучия (эмоционального, психологического и социального) [2–5]. Дифференцирующий подход строго ограничивает эти понятия, трактуя психическое здоровье в клиническом ключе (как отсутствие расстройств) [6–8]. В настоящем исследовании мы опираемся на третий – адаптационный подход. Его сторонники определяют здоровье как способность человека адаптироваться и управлять своим состоянием [9]. В рамках этой парадигмы фокус смещается на индивидуальное поведение. Отталкиваясь от концепции самосохранительного поведения [10], мы понимаем психическое здоровье как способность справляться с дистрессом, не допуская развития клинических форм тревоги и депрессии [11, 12] – ведущих причин инвалидности и преждевремен-

ной смертности [13, 14]. Забота о психическом здоровье концептуализируется как системное явление – от навыков саморегуляции до обращения к специалистам [15, 16], однако ключевым является то, что эти практики применяются не хаотично, а специфически комбинируются, образуя устойчивые поведенческие модели.

Особую актуальность изучение таких моделей приобретает в контексте урбанизированной среды обитания. Доля городского населения планеты, по прогнозам ООН, вырастет до 68 % к 2050 г., а Россия уже сегодня высоко урбанизирована (109,8 млн городских жителей против 36,3 млн сельских на начало 2025 г.)^{5,6}. Метаанализы показывают, что в городах уровень заболеваемости всеми психическими патологиями выше в среднем на 30 %, аффективными расстройствами – на 39 %, тревожными расстройствами – на 21 %, а риск развития шизофрении возрастает вдвое по сравнению с жителями сельских территорий [17]. По результатам современных обзоров, городской образ жизни ведет к росту распространенности психических нарушений среди населения [18, 19]. Основным механизмом выступает хронический «городской стресс», порождаемый совокупностью экологических (качество атмосферного воздуха, шум), социальных (изоляция, темп жизни, информационная перегруженность) и индивидуально-биографических (ранний жизненный опыт, специфика взросления в городской среде, история переездов) факторов [17, 20]. Риски для психического здоровья возрастают с переходом от сельских местностей к городам, причем качество среды выступает главным источником стресса, неодинаково влияя на жителей разных территорий. Среда задает разный темп жизни, определяет паттерны поведения и ценности горожан [21].

Мы используем термин «крупные города» в широком контексте, подразумевая под ними крупные урбанизированные центры, к которым относятся и города-миллионники (Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск). Такой подход позволяет сохранить преемственность с устоявшимся понятием «городской стресс», который традиционно связывают именно с крупными центрами, где жители в полной мере испытывают воздействие стрессоров, но при этом имеют определенную доступность ресурсов для поддержания здоровья. Это обуславливает значимость исследования того, как именно они воспринимают свое здоровье и какие практики заботы о психике они систематически выбирают.

В отечественной науке эмпирически подтверждена распространенность рутинных бытовых

¹ World Health Organization (WHO). WHO Global Meeting to Accelerate Progress on SDG target 3.4 on NCDs and Mental Health. 2019. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/09/default-calendar/ncds2019> (дата обращения: 17.07.2026).

² World Health Organization (WHO). Anxiety disorders. 2025. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders> (дата обращения: 17.07.2026).

³ Указ Президента РФ от 8 декабря 2025 г. № 896 «О Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года». [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413121153/> (дата обращения: 20.07.2026).

⁴ World Health Organization (WHO). Fact sheet: Mental health. 2025. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> (дата обращения: 19.07.2026).

⁵ Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 г. и в среднем за 2024 г. и компоненты ее изменения (Размещено 14.03.25) [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 15.07.2026).

⁶ Вся статистическая информация публикуется Росстатом без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

антистресс-практик (общения с близкими, спорт, медиа) [22] и «хэлсифицированного» потребления [16]. Значительная часть работ посвящена готовности россиян обращаться за профессиональной помощью, особенно среди узких демографических групп (молодежи [23], мужчин [24]). Однако, несмотря на детальное описание разрозненных действий, они изучаются преимущественно изолированно. В результате отдельные практики заботы не концептуализируются как целостные и устойчивые поведенческие модели, что не позволяет дифференцировать группы населения по типам поведения, а это необходимо для грамотного выстраивания адресной помощи городским жителям.

Цель исследования – выявить и описать поведенческие модели заботы о психическом здоровье среди жителей крупных городов России.

Материалы и методы. Исследование выполнено в логике микс-методологии (mixed methods approach), использовался объяснительный последовательный дизайн [25]. На первом этапе с помощью качественного анализа была построена типология поведенческих моделей заботы о психическом здоровье, на втором – эта типология легла в основу инструментария количественного опроса, позволяющего оценить распространенность выделенных моделей и связанные с ними факторы.

Материалом для качественного этапа исследования послужили личные полуструктурированные интервью с жителями (мужчинами и женщинами) Перми, Новосибирска и Нижнего Новгорода от 18 лет и старше, проведенные с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. ($n = 69$). Отбор информантов осуществлялся на основе целевой выборки, обеспечивающей максимальное типологическое разнообразие по социально-демографическим характеристикам (полу, возрасту, уровню образования, доходу и семейному положению). Чтобы избежать смысловых искажений, связанных с профессиональными навыками информантов, был введен критерий их исключения – наличие профильного медицинского образования, а также занятость в сфере здравоохранения и фармацевтики. Беседы опирались на разработанный исследовательским коллективом проекта № 23-18-00480-П путеводитель, охватывающий такие темы как субъективное восприятие психического здоровья, типичные стрессоры и триггеры, вызывающие тревожность, повседневные практики и копинг-стратегии совладания со стрессом, информированность о психических расстройствах (в частности, депрессии), а также установки по отношению к профессиональной психологической и психиатрической помощи. Все интервью с согласия информантов были записаны в аудио формате и впоследствии транскрибированы.

Обработка данных осуществлялась методами открытого и осевого кодирования.

Эмпирической базой количественного этапа стали результаты формализованного онлайн-опроса (март – апрель 20225 г., платформа Questionstar.ru⁷, $n = 2073$). Методология построения количественного инструментария (анкеты) опиралась на результаты качественного этапа исследования. Анализ нарративов информантов показал, что повседневные рутины заботы о психическом здоровье концентрируются вокруг четырех смысловых осей – отношение к проблеме, предпринимаемые действия, отношение к источникам помощи и информации. В соответствии с принципами обоснованной теории [26], именно эти эмпирически выделенные оси послужили критериями для построения и различения моделей заботы о психическом здоровье (активной, пассивной и игнорирующей). Для обеспечения конструктивной валидности каждый из критериев был операционализирован с помощью закрытого вопроса с тремя вариантами ответа, отражающими активную, пассивную или игнорирующую позиции⁸. Содержательная валидность обеспечивалась выведением формулировок вопросов напрямую из нарративов информантов (использовались лексические конструкты и смысловые паттерны).

Анкета состояла из трех блоков закрытых вопросов – 1) демографические вопросы (пол, возраст, семейное положение, доход и род занятий респондента), 2) четыре вопроса о практиках и смыслах заботы о психическом здоровье, конструирующие типологию моделей, 3) три вопроса о частоте переживания стресса, субъективной вероятности обращения за психологической помощью (5-ступенчатые шкалы Лайкерта) и конкретных практиках совладания (множественный выбор до трех вариантов), использовавшиеся для содержательного уточнения моделей.

На основе четырех критериальных вопросов (блок 2) для каждого респондента вычислялся профиль ответов – фиксировалось число выборов активной, пассивной или игнорирующей позиции (сумма по каждому типу – от 0 до 4). Типологическая принадлежность определялась по принципу доминирования (3 или 4 балла). При отсутствии явного доминирования (распределение 2/2 или 1/1/2) респондент классифицировался как представитель четвертой, ситуативной, модели. Введение данной модели расширило исходную типологию, учтя эмпирическую неоднородность поведения. Устойчивость типологии подтверждена двухэтапным кластерным анализом ($k = 4$).

Генеральная совокупность онлайн-опроса – взрослое население (18+) 13 из 16 российских городов-миллионников. Из анализа исключены Москва

⁷ Участие в исследовании было добровольным. Перед началом опроса на стартовой странице анкеты каждый респондент давал согласие на участие в исследовании и обработку предоставленных данных путем проставления соответствующей отметки в специальном электронном поле. Без подтверждения согласия доступ к вопросам анкеты не предоставлялся.

⁸ Критерий «отношение к проблеме» – вопрос «Что из перечисленного лучше всего отражает Ваше отношение к своему психическому здоровью?»; критерий «предпринимаемые действия» – вопрос «Как Вы обычно справляетесь с ситуациями, когда чувствуете сильный стресс или тревогу?»; критерий «отношение к источникам помощи» – вопрос «Что Вы думаете об обращении к психологу или психотерапевту?»; критерий «отношение к информации» – вопрос «Представьте, что Вы прочитали статью о том, что популярный метод борьбы со стрессом, которым пользуются многие Ваши знакомые, на самом деле может быть вредным для психического здоровья. Что бы Вы сделали в первую очередь?».

(из-за особого социально-экономического статуса), а также Ростов-на-Дону и Краснодар (геополитическая обстановка в них искажает оценку рисков здоровью и выбор способов самосохранения). Отбор проходил в два этапа. На первом этапе 13 городов были разделены на три подгруппы по числу жителей. В первой подгруппе (верхняя треть) в качестве репрезентирующего города выбран Новосибирск, во второй – Нижний Новгород, в третьей – Пермь. Выбранные города являются типичными для своих групп по социально-экономическим параметрам. На втором этапе методом потоковой выборки (распространение ссылок в мессенджерах и соцсетях) отбирались респонденты. Собран массив из 2215 анкет. После отбраковки неполных ответов итоговая выборка составила 2073 чел. (18–95 лет). Для устранения типичного онлайн-смещения в сторону женщин и молодежи применено математическое перевзвешивание в два шага. Сначала отдельно для трех территориальных массивов с учетом реального распределения населения по полу и возрасту (по данным Росстата⁹) внутри этих городов, затем объединенный массив корректировался с учетом демографического веса (доли населения) каждой макро-зоны в структуре генеральной совокупности.

В результате процедуры перевзвешивания распределение по полу и возрасту в итоговой выборке (табл. 1) полностью соответствует демографической структуре генеральной совокупности (мужчины – 42,7 %, женщины – 57,3 %).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения Jamovi (версия 2.7.38.0), распространяемого на условиях открытой лицензии GNU General Public License¹⁰. В работе использованы следующие методы статистического анализа: типологизация на основе композитного индекса, анализ таблиц сопряженности с применением критерия хи-квадрат Пирсона, кластерный анализ, бинарная логистическая регрессия, критерий Краскела – Уоллиса, а также коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Ограничения исследования. Основным ограничением выступает применение потоковой выборки, что несет риск систематической ошибки из-за самоотбора активных интернет-пользователей.

Кроме того, инструментарий опроса был направлен на фиксацию рутинных паттернов поведения («Как Вы обычно справляетесь...»), без дифференциации стрессоров по степени интенсивности (повседневные неприятности или критические жизненные события). Будущие исследования должны учитывать ситуативность выбора практик в зависимости от триггера, вызывающего психическое неблагополучие.

Результаты. Анализ нарративов позволил содержательно описать три идеальные поведенческие модели заботы о психическом здоровье – активную, пассивную и игнорирующую. Активная модель отличается высокой осознанностью ее представителей. Они хорошо распознают симптомы, воспринимают психическое здоровье как ценность и применяют проактивные практики, а также склонны к рефлексии и демонстрируют базовое доверие к профессиональной помощи. Пассивная модель описывает людей, которые умеют признавать проблемы, но им не хватает внутренних ресурсов для системной работы с причинами. Их действия носят реактивный характер, сводясь к эскапизму и временному отвлечению, отношение к специалистам нейтрально, но на практике обращение к ним откладывается или замещается рутинными бытовыми действиями. Игнорирующая модель определяет такие паттерны, как вытеснение и отрицание проблем. Значимость психического состояния обесценивается в пользу физического здоровья и внешней продуктивности («надо быть сильным»). Целенаправленные действия в отношении психического здоровья отсутствуют или не осознаются, а отношение к профессиональной помощи носит выражено скептический и стигматизирующий характер.

Данные количественного исследования подтверждают существование нескольких устойчивых поведенческих моделей заботы о психическом здоровье среди жителей обследованных городов России, при этом различия между городами носят умеренный характер. Анализ линейных распределений позволяет охарактеризовать общий фон психического здоровья исследуемых территорий (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2, более трети опрошенных (38,2 %) сталкиваются с сильным стрессом «часто»

Таблица 1. Структура анализируемой выборочной совокупности (%)

Table 1. The structure of the surveyed sample (%)

Показатель / Indicator		В целом по выборке / Overall sample	Новосибирск / Novosibirsk	Нижний Новгород / Nizhny Novgorod	Пермь / Perm
Пол / Sex	Мужской / Male	42,7	43,3	42,1	42,6
	Женский / Female	57,3	56,7	57,9	57,4
Возраст, лет / Age, years	18–29	15,2	15,6	13,9	16,0
	30–39	21,0	21,9	19,5	21,4
	40–49	19,7	20,0	19,3	19,6
	50–59	14,9	14,3	15,4	15,1
	60–69	15,6	14,8	17,2	14,9
	≥ 70	13,7	13,4	14,6	13,1

⁹ Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения: 20.07.2026).

¹⁰ Проект jamovi (2026). jamovi (Version 2.7) [Компьютерная программа]. Режим доступа: <https://www.jamovi.org>.

Таблица 2. Субъективное переживание стресса, практики совладания и готовность обращаться за психологической помощью (%)

Table 2. Subjective experience of stress, coping practices, and willingness to seek psychological help (%)

Показатель / Indicator		В целом по выборке / Overall sample	Новосибирск / Novosibirsk	Нижний Новгород / Nizhny Novgorod	Пермь / Perm
Как часто Вы испытываете стресс? / How often do you feel stressed?	Очень часто / Часто / Very often / Often	38,2	35,4	40,0	40,7
	Иногда / Sometimes	41,1	40,4	44,7	37,6
	Редко / Никогда / Rarely / Never	20,7	24,2	15,3	21,7
Какие способы Вы используете для снятия стресса? (можно отметить не более 3 вариантов ответов) *множественный выбор (процент наблюдений) / What methods do you use to relieve stress? (You may select up to 3 options) *multiple choice (percentage of responses)	Общение с друзьями и семьей / Communicating with friends and family	52,6	50,9	52,2	56,0
	Хобби / Hobbies	24,9	24,9	22,9	27,3
	Прослушивание музыки / Listening to music	28,2	27,0	27,0	31,9
	Чтение / Reading	15,1	15,1	15,6	14,5
	Просмотр фильмов / Watching films	27,4	28,8	25,7	27,2
	Религиозная практика / Religious practice	6,9	9,6	5,8	3,6
	Медитация / Йога / Meditation / Yoga	4,9	6,5	2,2	5,8
	Прогулки на природе / Nature walks	34,0	33,3	34,9	34,0
	Занятия спортом / Sporting activities	25,4	30,8	19,5	24,0
	Обращение к психологу/психотерапевту / Consulting a psychologist/psychotherapist	4,4	6,4	2,3	3,7
	Употребление алкоголя / Alcohol consumption	13,6	15,2	10,7	14,5
	Никакие / None	7,7	6,8	9,2	7,3
Оцените, насколько вероятно, что Вы обратитесь за квалифицированной психологической помощью (к психологу/психотерапевту) в сложной жизненной ситуации? (оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – маловероятно, а 5 – очень вероятно) / How likely are you to seek professional psychological help (from a psychologist or psychotherapist) when facing a difficult situation in your life? (Rate on a scale of 1 to 5, where 1 is 'unlikely' and 5 is 'highly likely')	1 Маловероятно/2 / 1 unlikely / 2	47,7	45,4	46,1	53,5
	3	23,2	22,9	26,0	19,9
	4 / 5 Очень вероятно / 4 / 5 Highly likely	29,1	31,6	27,8	26,6

или «очень часто», что подтверждает тезис о высокой стрессогенности городской среды. При этом основным ресурсом совладания для большинства горожан остается неформальная поддержка друзей и семьи (52,6 %), тогда как за профессиональной помощью обращаются 4,4 % респондентов. Межгородские сравнения показывают высокую степень однородности ответов.

Построение композитного индекса, объединяющего четыре индикатора модели поведения (осознание проблемы, предпринимаемые действия, отношение к источникам помощи и информации), позволило распределить респондентов по четырем типам (см. табл. 3).

Ядро активной модели составило 23,2 % выборки, ядро пассивной модели – 22,5 %, то есть по

своей распространенности эти два типа оказались сопоставимы. Существенно меньшую долю (10,7 %) составило ядро игнорирующей модели. Наиболее многочисленной (43,5 %) оказалась группа, не имеющая доминирующего типа поведения, условно обозначенная как «Ситуативная» модель. Респонденты этой группы демонстрируют сочетание активных, пассивных и игнорирующих реакций в зависимости от конкретной ситуации, не будучи последовательными приверженцами ни одной из трех идеальных моделей.

Верификация методом кластерного анализа ($k = 4$) дала сопоставимое по размеру групп распределение (16,5 / 25,2 / 27,2 / 31,1 %), что косвенно указывает на устойчивость четырехчастной структуры поведенческих моделей, полученной на основе индексного

Таблица 3. Распределение по типу модели (%)

Table 3. Distribution by model type (%)

Показатель / Indicator	В целом по выборке / Overall sample	Новосибирск / Novosibirsk	Нижний Новгород / Nizhny Novgorod	Пермь / Perm
Активный / Active	23,2	22,6	27,2	19,1
Пассивный / Passive	22,5	24,1	21,2	21,5
Игнорирующий / Neglectful (ignoring)	10,7	10,7	9,0	12,8
Ситуативный / Context-dependent	43,5	42,5	42,5	46,6

подхода. Также подтверждением его валидности стали результаты кросс-табуляции, показавшие принадлежность одних и тех же респондентов к соответствующим группам как в индексной, так и в кластерной классификации. Почти все респонденты (96,1 %), отнесенные по индексу к «игнорирующей» модели, были объединены в один кластер. Аналогичное совпадение зафиксировано для «пассивной» модели (в единый кластер попали 81,2 % ее представителей по индексной классификации). Респонденты, принадлежащие к «активной» модели (98,8 %), были сгруппированы в два обособленных кластера (60,8 и 38,0 %), что указывает на внутреннюю неоднородность самой активной модели. Как показывает дальнейший анализ антистрессовых практик (см. табл. 3), данная неоднородность объясняется различием в проактивном поведении респондентов, когда большинство представителей «активного» типа опирается на самостоятельные практики (занятие спортом, хобби и т. п.), тогда как обращение к психологу является более редким явлением. Ситуативная модель, согласно логике ее концептуализации как эклектической, ожидаемо не образовала отдельного математического кластера – респонденты этой группы равномерно распределились между остальными кластерами.

Для оценки влияния социально-демографических характеристик (пол, возраст, наличие партнера, наличие детей до 18 лет, образование, занятость и уровень дохода) на выбор модели проведены бинарные логистические регрессии.

Активная модель статистически значима ($\chi^2 = 33,571$; $p < 0,001$), но ее объяснительная способность низкая (R^2 Нэйджелкерка = 0,024). Значимыми предикторами выступили пол ($B = 0,293$; $\text{Exp}(B) = 1,341$; $p = 0,007$) и возраст ($B = -0,165$; $\text{Exp}(B) = 0,847$; $p < 0,001$): модель наиболее характерна для молодых женщин, а вероятность принадлежности к ней снижается с возрастом. Она хорошо согласована с данными (по тесту Хосмера – Лемешева $\chi^2 = 8,202$; $p = 0,414$), а общий процент правильной классификации составил 54,8 %.

Для пассивной модели совокупный вклад предикторов незначим ($\chi^2 = 12,197$; $p = 0,094$; R^2 Нэйджелкерка = 0,009), а качество неудовлетворительно ($p = 0,008$). Можно отметить лишь слабую тенденцию к тому, что респонденты с детьми чаще относятся к пассивной модели, чем респонденты без детей ($B = -0,241$; $\text{Exp}(B) = 0,786$; $p = 0,045$; точность классификации – 58,1 %).

Игнорирующая модель показала наилучший, хотя и невысокий, результат ($\chi^2 = 93,835$; $p < 0,001$), однако

доля объяснительной дисперсии также небольшая (R^2 Нэйджелкерка = 0,090). Значимыми предикторами выступили пол ($B = -0,873$; $\text{Exp}(B) = 0,418$; $p < 0,001$), возраст ($B = 0,402$; $\text{Exp}(B) = 1,495$; $p < 0,001$), образование ($B = -0,282$; $\text{Exp}(B) = 0,754$; $p = 0,011$) и уровень дохода ($B = 0,345$; $\text{Exp}(B) = 1,412$; $p = 0,002$). Мужчины значимо чаще женщин демонстрируют игнорирующую модель; вероятность ее выбора растет с возрастом и с уровнем дохода, но снижается с ростом уровня образования – то есть игнорирующая модель наиболее характерна для мужчин старшего возраста с более высоким доходом и более низким уровнем образования. Тест Хосмерат – Лемешева не выявил значимых расхождений ($\chi^2 = 8,039$; $p = 0,430$). Общий процент правильной классификации – 63,0 %.

Наконец, ситуативный тип ожидаемо не обнаружил значимой связи ни с одним из предикторов ($\chi^2 = 11,463$; $p = 0,120$; R^2 Нэйджелкерка = 0,007; точность – 53,0 %), ближе всего к значимости оказалось наличие детей ($p = 0,051$). Тест Хосмера – Лемешева подтвердил хорошее согласие модели с данными ($\chi^2 = 5,088$; $p = 0,748$), однако низкая объяснительная способность говорит о том, что рассмотренные переменные слабо предсказывают принадлежность к этому типу.

Низкие значения коэффициента детерминации (R^2 Нэйджелкерка) во всех регрессиях показывают, что социально-демографические характеристики слабо определяют поведенческий выбор. Принадлежность к модели, вероятнее всего, обусловлена иными факторами, например ценностными установками, индивидуально-психологическими особенностями, уровнем рефлексии или спецификой конкретной стрессовой ситуации, что косвенно подтверждается высокой долей респондентов, относящихся к ситуативной модели поведения.

Анализ антистрессовых практик показал наличие как универсальных, так и дифференцирующих паттернов (см. табл. 4). Универсальной практикой для всех типов моделей выступило общение с друзьями и семьей (несмотря на статистически значимые колебания частот $\chi^2 = 21,91$; $p = 0,001$), что подтверждает ключевую роль социальной поддержки как базового ресурса совладания со стрессом в городской среде. Прогулки на природе также входят в топ-2 практик у каждого типа, за исключением активного, где они значимо чаще замещаются высокими показателями хобби ($\chi^2 = 19,12$; $p = 0,004$) и занятий спортом ($\chi^2 = 19,53$; $p = 0,003$).

Проверка статистической значимости различий (с помощью критерия хи-квадрат Пирсона) позволила

выделить достоверные маркеры для каждой группы. Для респондентов, реализующих активную модель, таким маркером выступает обращение к психологу (7,5 %), что является максимальным показателем среди всех типов ($\chi^2 = 38,93$; $p < 0,001$). Опрошенные, относящиеся к пассивной поведенческой модели, отличаются наиболее высоким уровнем употребления алкоголя – 24,4 % ($\chi^2 = 44,62$; $p < 0,001$), что в сочетании с низкой долей конструктивных практик (обращение к психологу – 3,6 %) указывает на замещение активных стратегий деструктивными. Для людей с игнорирующей моделью поведения характерны избегающие паттерны, маркером для этой группы выступает максимальная доля отрицания стресса («никакие» способы – 16,5 %, $\chi^2 = 55,09$; $p < 0,001$), при этом практика обращения к психологу практически отсутствует (0,3 %). Горожане, склонные к ситуативной модели, занимают промежуточную позицию, используя эклектичный набор практик без ярко выраженных статистических отклонений от средних значений (табл. 4).

Дополнительным подтверждением содержательной валидности предложенной типологии выступили результаты сравнения респондентов, демонстрирующих разные поведенческие модели, по показателям субъективного переживания стресса и их гипотетической готовности обращения за психологической помощью. Критерий Краскела – Уоллиса зафиксировал статистически значимые различия по обоим показателям ($\chi^2 = 102,115$ и $\chi^2 = 200,738$ соответственно; $df = 3$; $p < 0,001$). Наиболее высокой готовность обратиться за квалифицированной помощью оказалась у респондентов, реализующих активную модель, тогда как у представителей игнорирующей модели этот показатель оказался минимальным. Опрошенные, отнесенные к пассивной и ситуативной моделям, заняли промежуточное положение. Такое распределение напрямую соответствует уже описанным поведенческим маркерам типов – максимальной доле фактического обращения к психологу среди представителей активной модели (7,5 %) и практи-

чески полному отсутствию такой практики в группе игнорирующей модели (0,3 %).

При анализе частоты переживания стресса была выявлена менее очевидная, но содержательно значимая закономерность. У респондентов с игнорирующей моделью поведения зафиксирован наивысший средний ранг, то есть они реже остальных признают у себя наличие стресса. Напротив, горожане, демонстрирующие пассивную модель заботы о психическом здоровье, сообщают о стрессе чаще всех. Это указывает на то, что специфика игнорирующей модели обусловлена не отсутствием стрессовой нагрузки как таковой, а специфическим механизмом ее отрицания и вытеснения, что согласуется с ранее описанными избегающими паттернами у данной группы респондентов.

Особый интерес представляет анализ связи между двумя показателями внутри каждой модели с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r_s). Среди респондентов, реализующих активную ($r_s = -0,184$; $p < 0,001$) и ситуативную ($r_s = -0,135$; $p = 0,001$) модели, более частое переживание стресса ассоциируется с большей готовностью обратиться за помощью (отрицательный знак коэффициентов обусловлен обратным кодированием шкалы частоты стресса в анкете), что отражает адаптивную, ожидаемую логику заботы о психическом здоровье. В группе, относящейся к пассивной модели, данная связь оказалась статистически незначимой ($r_s = -0,040$; $p = 0,401$). Это может указывать, что субъективное переживание стресса не конвертируется у них в готовность искать профессиональную помощь. Для людей, склонных к игнорирующей модели, была зафиксирована статистически значимая связь противоположного направления ($r_s = +0,211$; $p = 0,002$), респонденты этого типа, реже признающие у себя стресс, демонстрируют более высокую готовность обратиться к специалисту, тогда как более выраженное переживание стресса сопровождается снижением этой готовности. Разнонаправленность связи говорит о защитном механизме избегания, лежащем в основе

Таблица 4. Способы снятия стресса: доминирующий вариант по каждой модели (%)

Table 4. Stress coping strategies: The dominant option for each model (%)

Способ снятия стресса / Stress coping strategy	Активная / Active	Пассивная / Passive	Игнорирующая / Neglectful	Ситуативная / Situational
Общение с друзьями и семьей / Communication with friends and family	55,6	49,9	39,6	55,5
Прогулки на природе / Nature walks	28,5	31,0	32,6	38,8
Прослушивание музыки / Listening to music	33,6	28,5	19,4	27,4
Просмотр фильмов / Watching films	30,4	28,8	22,5	26,3
Занятия спортом / Sporting activities	31,1	26,2	12,3	25,2
Хобби / Hobbies	34,1	21,4	16,6	23,7
Чтение / Reading	12,9	12,1	23,3	15,8
Употребление алкоголя / Alcohol consumption	4,6	24,4	13,0	13,0
Медитация / Yoga / Meditation / Yoga	10,0	3,2	0,4	4,2
Никакие / None	3,6	4,9	16,5	9,1
Обращение к психологу/психотерапевту / Consulting a psychologist/psychotherapist	7,5	3,6	0,3	4,1
Религиозная практика / Religious practice	4,0	10,0	15,2	4,7

игнорирующей модели. Признание стресса может восприниматься как сигнал к действию, поэтому, пока стресс не признан, действовать не нужно.

Обсуждение. Наиболее многочисленной в выборке оказалась ситуативная модель поведения (43,5 %), которая указывает на отсутствие устойчивого набора поведенческих паттернов. Самоохранительное поведение в части заботы о психическом здоровье у представителей этой группы носит выраженно дискретный характер и этот результат отражает тренды. В недавних исследованиях подтверждается преобладание «реактивного» подхода, когда люди в целом склонны применять здоровьесберегающие практики не превентивно, а лишь в моменты критических сбоев [27]. Формированию устойчивых поведенческих рутин препятствуют такие универсальные барьеры, как дефицит психологической грамотности и стигматизация [28]. Эта дискретность и доминирование ситуативной модели являются следствием специфики жизни в крупном городе [17, 20], которая выступает не только источником стресса, но и фактором, определяющим способы совладания с ним. Высокий темп жизни и хронический дефицит времени блокируют формирование сложных, систематических рутин самозаботы. В условиях информационной и временной перегрузки люди склонны выбирать наиболее быстрые и ситуативно доступные ресурсы для снятия напряжения, откладывая энергос затратный поиск профессиональной помощи до момента острой необходимости [29]. Горожане комбинируют паттерны из разных поведенческих моделей, чему способствует доступность информации о самопомощи¹¹. По данным ВЦИОМ, 86 % населения никогда не обращались за профессиональной психологической помощью¹², предпочитая справляться самостоятельно [30]. Поэтому доля респондентов, отнесенных к активной модели (23,2 %), может быть несколько завышена из-за эффекта социальной желательности. В последние годы забота о ментальном здоровье активно популяризируется в медиа, формируя социально одобряемый образ «осознанного» человека. Современные методологические исследования доказывают, что при опросах на сензитивные темы респонденты склонны завышать частоту использования конструктивных практик и свою гипотетическую готовность обратиться к специалисту, маскируя реальные барьеры (например, стыд) стремлением дать «правильный» ответ [31]. Выбор же пассивной или игнорирующей модели часто является не следствием неосведомленности, а осознанным решением при сильных психологических барьерах. Настороженность горожан по отношению к психологам напрямую связана с высокой сензи-

тивностью темы и сохраняющейся стигматизацией психических расстройств. Эмпирические данные подтверждают, что страх стигматизации и боязнь осуждения со стороны общества остаются главными препятствиями для поиска институциональной помощи в России [32, 33].

Социально-демографические факторы (пол, возраст, доход, образование) объяснили менее 10 % дисперсии в выборе модели, за исключением профиля «игнорирующих». Поведение определяется скорее контекстом и установками, чем демографическим профилем [34]. Данные по этому вопросу противоречивы. В американском исследовании установок пациентов первичной помощи пол, доход и другие социально-демографические параметры не предсказывали готовность обращаться за ней [35]. В Бангладеш единственным значимым предиктором оказалось наличие расстройства у родственника [36]. Среди женщин с тревогой и депрессией обращаемость предсказывали занятость, самостоятельность, влияние СМИ и наличие тревоги/депрессии, а не образование, религия или др. [37]. Лонгитюдные данные по британской молодежи (16–24 лет) подтверждают связь низкого дохода с тревогой и депрессией [38]. В американском исследовании высокий уровень образования может усиливать избегающее поведение – информированность не равнозначна готовности решать проблему, а барьером становятся установки, связанные с ощущением постыдности расстройства [35].

По данным панельного исследования НИУ ВШЭ¹³ отсутствие высшего образования снижает вероятность обращения к психотерапевту. В этом же исследовании показана устойчивую связь опыта обращения к психотерапевту с социально-демографическими характеристиками (пол, социально-экономический статус, семейное положение, наличие детей), личностными чертами (частота стресса, независимость, локус контроля) и установками к психотерапии [23]. Однако эти данные относятся к панельной молодежной когорте (средний возраст 26 лет), тогда как наш опрос охватывает разные возрастные группы и построен на ином дизайне, что усложняет прямое сопоставление.

Мужчины реже обращаются за психологической помощью [23] и хуже женщин распознают симптомы, что ведет к отрицанию необходимости помощи и игнорирующей модели [24]. В пассивной модели конструктивные практики совладания со стрессом заменяются деструктивными, прежде всего алкоголем, с ростом суицидов среди мужчин¹⁴.

Заключение. В исследовании методологически обоснована и валидирована четырехчастная типология поведенческих моделей заботы о психи-

¹¹ WHO. Self-care for health and well-being. 2026. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/self-care-health-interventions> (дата обращения: 20.07.2026).

¹² ВЦИОМ. Индекс потребности россиян в психологической поддержке. 10 февраля 2025 г. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/indeks-potrebnosti-rossijan-v-psikhologicheskoi-podderzhke> (дата обращения 20.07.2026).

¹³ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

¹⁴ Сводный доклад №70 Сети фактических данных по вопросам здоровья. Психическое здоровье, мужчины и культурные традиции: как социокультурные конструкты, связанные с проявлениями маскулинности, влияют на обращаемость мужчин за психиатрической помощью в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/c3067ae3-f684-4b4b-8d7b-5624b3ba2130/content> (дата обращения: 20.07.2026)

ческом здоровье горожан, включающая активную, пассивную, игнорирующую и ситуативную модели. Наиболее проблемной выступает игнорирующая модель (характерная для мужчин и людей старшего возраста), представители которой систематически отрицают стресс, избегают помощи и невосприимчивы к разнообразному и богатому в настоящее время контенту. Работа с представителями этой и пассивной модели требует дестигматизации сферы психического здоровья, преодоления гендерного стереотипа «мужчина должен справляться сам» и позиционирования обращения к специалисту как проявления ответственности, а не слабости. Доминирование ситуативной модели диктует необходимость развития форматов помощи «низкого порога входа», интегрированных в повседневную среду (кабинеты разгрузки на рабочих местах, доступные онлайн-сервисы). Подобные меры позволят конвертировать фрагментарные, реактивные попытки горожан справиться с проблемами в устойчивые рутины заботы о психическом здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137–150. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00395-3
- Magomedova A, Fatima G. Mental health and well-being in the modern era: A comprehensive review of challenges and interventions. *Cureus*. 2025;17(1):e77683. doi: 10.7759/cureus.77683
- Magalhães E. Dual-factor models of mental health: A systematic review of empirical evidence. *Psychosoc Interv*. 2024;33(2):89–102. doi: 10.5093/pi2024a6
- Polujanski S, Nett U, Rotthoff T, Oezsoy M, Schindler AK. Uncovering heterogeneity in mental health changes among first-year medical students. *Med Educ Online*. 2024;29(1):2317493. doi: 10.1080/10872981.2024.2317493
- Medina-Rodríguez JC. The philosophical foundations of a multidisciplinary approach to psychiatry. *Cureus*. 2025;17(3):e80899. doi: 10.7759/cureus.80899
- Bolton D. A revitalized biopsychosocial model: Core theory, research paradigms, and clinical implications. *Psychol Med*. 2023;53(16):7504–7511. doi: 10.1017/S0033291723002660
- Gautam S, Jain A, Chaudhary J, Gautam M, Gaur M, Grover S. Concept of mental health and mental well-being, its determinants and coping strategies. *Indian J Psychiatry*. 2024;66(Suppl 2):S231–S244. doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_707_23
- Weich S, Brugha T, King M, et al. Mental well-being and mental illness: Findings from the Adult Psychiatric Morbidity Survey for England 2007. *Br J Psychiatry*. 2011;199(1):23–28. doi: 10.1192/bjp.bp.111.091496
- Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? *BMJ*. 2011;343:d4163. doi: 10.1136/bmj.d4163
- Lazarus R, Folkman S. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer; 1984.
- Salaheddin K, Mason B. Identifying barriers to mental health help-seeking among young adults in the UK: A cross-sectional survey. *Br J Gen Pract*. 2016;66(651):e686–e692. doi: 10.3399/bjgp16X687313
- Woo J, Whyne EZ, Steinhart MA. Psychological distress and self-reported mental disorders: The partially mediating role of coping strategies. *Anxiety Stress Coping*. 2024;37(2):180–191. doi: 10.1080/10615806.2023.2258805
- Белялов Ф.И. Депрессия, тревога, стресс и смертность // Терапевтический архив. 2016. Т. 88. № 12. С. 116–119. doi: 10.17116/terarkh20168812116–119. EDN XROGLD.
- Chodavadia P, Teo I, Poremski D, Fung DSS, Finkelstein EA. Prevalence and economic burden of depression and anxiety symptoms among Singaporean adults: Results from a 2022 web panel. *BMC Psychiatry*. 2023;23(1):104. doi: 10.1186/s12888-023-04581-7
- Лебедева-Несевря Н.А., Леукина А.В., Сирковская Т.В. Практики заботы о ментальном здоровье в самосохранительных стратегиях россиян // Журнал социологии и социальной антропологии. 2025. Т. 28. №2. С. 119–153. doi: 10.31119/jssa.2025.28.2.5. EDN EROSMY.
- Бердышева Е.С. Ценности самозаботы: «энтузиасты здоровья» и хэлсифицированное потребление // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 1. С. 58–88. doi: 10.19181/inter.2022.14.1.3. EDN WSGAWD.
- Кияненко И.К. Влияние стресс-факторов городской среды на психическое здоровье: обзор зарубежных исследований // Клиническая и специальная психология. 2026. Т. 15. № 1. С. 7–19. doi: 10.17759/cpse.2026150101. EDN RBFZBO.
- Peen J, Schoevers RA, Beekman AT, Dekker J. The current status of urban-rural differences in psychiatric disorders. *Acta Psychiatr Scand*. 2010;121(2):84–93. doi: 10.1111/j.1600-0447.2009.01438.x
- Синева И.М., Хафизова А.А., Пермяков И.А. Гигиенические детерминанты психического здоровья городского населения: обзор литературы // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. №11. С. 67–75. doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-11-67-75. EDN OPDDIE.
- Lederbogen F, Kirsch P, Haddad L, et al. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*. 2011;474(7352):498–501. doi: 10.1038/nature10190
- Алескеров У.Э. Взгляд на город: как психология формирует восприятие пространства // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2025. № 4(74). doi: 10.48612/NewsKSUA/74.19. EDN SMPWCX.
- Аксенова Е.И., Камынина Н.Н., Турзин П.С. Городской стресс жителя мегаполиса: стрессогенные факторы и коррекция // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023. Т. 31. №52. С. 1087–1091. doi: 10.32687/0869-866X-2023-31-s2-1087-1091. EDN FSFPJJ.
- Лукина А.А., Бочкор А.И. Терапевтический поворот на пути российской молодежи: факторы обращения за психотерапевтической помощью // Социологические исследования. 2025. № 3. С. 90–104. doi: 10.7868/S3034601025030089. EDN KLTQZI.
- Аникина В.О., Попова А.Г., Васильева Н.Л. Субъективные факторы обращения за психологической помощью мужчин // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8. №5. С. 26. EDN KXZKTI.
- Jackson-Gordon R, Plano Clark VL. Using a joint display for building integration in a sequential study: Informing data collection for a participatory second phase. *J Mix Methods Res*. 2024;18(2):137–146. doi: 10.1177/15586898231179848
- Shrestha PR. Grounded theory as a qualitative research method. *JOVAC*. 2025;2(1):114–134. doi: 10.3126/jovac.v2i1.83882
- Назарова И.Б. Самосохранительные практики населения // Вопросы управления. 2024. №4(89). С. 41–53. doi: 10.22394/2304-3369-2024-4-41-53. EDN PHDXEM.

28. Bora S, Biswal B, Gandhi Y, et al. Interventions to improve mental health help-seeking attitudes, intentions and behaviors: A systematic review of recent advances. *Glob Ment Health (Camb)*. 2026;13:e85. doi: 10.1017/gmh.2026.10183
29. Jaggi SK, Gupta DJ. Chronically busy, chronically unhealthy? Understanding the time poverty and health interplay through systematic review synthesis. *Cogent Soc Sci*. 2025;11(1):2491707. doi: 10.1080/23311886.2025.2491707
30. Norcross JC. Here comes the self-help revolution in mental health. *Psychotherapy*. 2000;37(4):370-377. doi: 10.1037/0033-3204.37.4.370
31. Lee A, Iskandar A. Social desirability and its effect on help-seeking: Mediated by shame. *JAYPS*. 2025;6(5):11. doi: 10.61838/kman.jayps.6.5.11
32. Семелёва Е.В. Ментальное здоровье населения России // Международный научно-исследовательский журнал. 2025. №1(151). С. 91. doi: 10.60797/IRJ.2025.151.99. EDN BUXDRZ.
33. Пыжова О.В., Часовских Е.Е. Проблема стигматизации психически больных в России // Innova. 2024. Т.10. №1. С. 47–50. EDN WZLUUH.
34. Leslie-Miller CJ, Joormann J, Quinn ME. Coping flexibility: Match between coping strategy and perceived stressor controllability predicts depressed mood. *Affect Sci*. 2024;6(1):94-103. doi: 10.1007/s42761-024-00275-9
35. Benuto LT, Casas J, Gonzalez F, Newlands R. The behavioral model of health: Education, behavioral health factors, and stigma as predictors of help-seeking attitudes. *Community Ment Health J*. 2020;56(7):1275-1283. doi: 10.1007/s10597-020-00601-y
36. Huque R, Azad AK, Islam K, Ahmed HU, Amin MR. Mental health care seeking behavior in Bangladesh: Determinants and treatment gaps. *BMC Psychiatry*. 2025;25(1):779. doi: 10.1186/s12888-025-06813-4
37. Walter H, Craig ME, Ali M, Faruque S, Saha S. Seeking support: Insights into women's mental health help-seeking behavior in Bangladesh. *Front Glob Womens Health*. 2025;6:1679141. doi: 10.3389/fgwh.2025.1679141
38. Parra-Mujica F, Johnson E, Reed H, Cookson R, Johnson M. Understanding the relationship between income and mental health among 16- to 24-year-olds: Analysis of 10 waves (2009–2020) of Understanding Society to enable modelling of income interventions. *PLoS One*. 2023;18(2):e0279845. doi: 10.1371/journal.pone.0279845
39. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137-150. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00395-3
40. Magomedova A, Fatima G. Mental health and well-being in the modern era: A comprehensive review of challenges and interventions. *Cureus*. 2025;17(1):e77683. doi: 10.7759/cureus.77683
41. Magalhães E. Dual-factor models of mental health: A systematic review of empirical evidence. *Psychosoc Interv*. 2024;33(2):89-102. doi: 10.5093/pi2024a6
42. Polujanski S, Nett U, Rothhoff T, Oezsoy M, Schindler AK. Uncovering heterogeneity in mental health changes among first-year medical students. *Med Educ Online*. 2024;29(1):2317493. doi: 10.1080/10872981.2024.2317493
43. Medina-Rodríguez JC. The philosophical foundations of a multidisciplinary approach to psychiatry. *Cureus*. 2025;17(3):e80899. doi: 10.7759/cureus.80899
44. Bolton D. A revitalized biopsychosocial model: Core theory, research paradigms, and clinical implications. *Psychol Med*. 2023;53(16):7504-7511. doi: 10.1017/S0033291723002660
45. Gautam S, Jain A, Chaudhary J, Gautam M, Gaur M, Grover S. Concept of mental health and mental well-being, its determinants and coping strategies. *Indian J Psychiatry*. 2024;66(Suppl 2):S231-S244. doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_707_23
46. Weich S, Brugha T, King M, et al. Mental well-being and mental illness: Findings from the Adult Psychiatric Morbidity Survey for England 2007. *Br J Psychiatry*. 2011;199(1):23-28. doi: 10.1192/bjp.bp.111.091496
47. Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? *BMJ*. 2011;343:d4163. doi: 10.1136/bmj.d4163
48. Lazarus R, Folkman S. *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer; 1984.
49. Salaheddin K, Mason B. Identifying barriers to mental health help-seeking among young adults in the UK: A cross-sectional survey. *Br J Gen Pract*. 2016;66(651):e686-e692. doi: 10.3399/bjgp16X687313
50. Woo J, Whyne EZ, Steinhart MA. Psychological distress and self-reported mental disorders: The partially mediating role of coping strategies. *Anxiety Stress Coping*. 2024;37(2):180-191. doi: 10.1080/10615806.2023.2258805
51. Belialov FI. Depression, anxiety, stress, and mortality. *Terapevticheskiy Arkhiv*. 2016;88(12):116-119. (In Russ.) doi: 10.17116/terarkh20168812116-119
52. Chodavadia P, Teo I, Poremski D, Fung DSS, Finkelstein EA. Prevalence and economic burden of depression and anxiety symptoms among Singaporean adults: Results from a 2022 web panel. *BMC Psychiatry*. 2023;23(1):104. doi: 10.1186/s12888-023-04581-7
53. Lebedeva-Nesevria NA, Leukhina AV, Sirkovskaya TV. Caring for mental health in the self-preservation strategies of Russians. *Zhurnal Sotsiologii i Sotsial'noy Antropologii*. 2025;28(2):119-153. (In Russ.) doi: 10.31119/jssa.2025.28.2.5
54. Berdysheva ES. The value of self-care: „Health Enthusiasts” and Healthified Consumption. *Interaktsiya. Interv'yu. Interpretatsiya*. 2022;14(1):58-88. (In Russ.) doi: 10.19181/inter.2022.14.1.3
55. Kiyanenko IK. The impact of urban stress factors on mental health: A review of foreign studies. *Klinicheskaya i Spetsial'naya Psikhologiya*. 2026;15(1):7-19. (In Russ.) doi: 10.17759/cpse.2026150101
56. Peen J, Schoevers RA, Beekman AT, Dekker J. The current status of urban-rural differences in psychiatric disorders. *Acta Psychiatr Scand*. 2010;121(2):84-93. doi: 10.1111/j.1600-0447.2009.01438.x
57. Sineva IM, Khafizova AA, Permyakov IA. Environmental determinants of urban mental health: A literature review. *Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya*. 2021;29(11):67-75. (In Russ.) doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-11-67-75
58. Lederbogen F, Kirsch P, Haddad L, et al. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*. 2011;474(7352):498-501. doi: 10.1038/nature10190
59. Alasgarov UE. City view: How psychology shapes our perception of space. *Izvestiya Kazanskogo Gosudarstvennogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta*. 2025;(4(74)):217-228. (In Russ.) doi: 10.48612/NewsK-SUAE/74.19
60. Aksenova EI, Kamynina NN, Turzin PS. Urban stress of a megalopolis resident: Stress factors and correction. *Problemy Sotsial'noy Gigieny, Zdravookhraneniya i Istorii Meditsini*. 2023;31(S2):1087-1091. (In Russ.) doi: 10.32687/0869-866X-2023-31-s2-1087-1091
61. Lukina AA, Bochkor AI. Therapeutic turn on the path of Russian youth: Factors for seeking psychotherapeutic

REFERENCES

- help. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2025;(3):90-104. (In Russ.) doi: 10.31857/S0132162525030089
24. Anikina VO, Popova AG, Vasilyeva NL. What stops men from seeking psychological help? *Mir Nauki. Pedagogika i Psikhologiya*. 2020;8(5):26. (In Russ.)
 25. Jackson-Gordon R, Plano Clark VL. Using a joint display for building integration in a sequential study: Informing data collection for a participatory second phase. *J Mix Methods Res*. 2024;18(2):137-146. doi: 10.1177/15586898231179848
 26. Shrestha PR. Grounded theory as a qualitative research method. *JOVAC*. 2025;2(1):114-134. doi: 10.3126/jovac.v2i1.83882
 27. Nazarova IB. Self-preservation practices of the population. *Voprosy Upravleniya*. 2024;(4(89)):41-53. (In Russ.) doi: 10.22394/2304-3369-2024-4-41-53
 28. Bora S, Biswal B, Gandhi Y, et al. Interventions to improve mental health help-seeking attitudes, intentions and behaviors: A systematic review of recent advances. *Glob Ment Health (Camb)*. 2026;13:e85. doi: 10.1017/gmh.2026.10183
 29. Jaggi SK, Gupta DJ. Chronically busy, chronically unhealthy? Understanding the time poverty and health interplay through systematic review synthesis. *Cogent Soc Sci*. 2025;11(1):2491707. doi: 10.1080/23311886.2025.2491707
 30. Norcross JC. Here comes the self-help revolution in mental health. *Psychotherapy*. 2000;37(4):370-377. doi: 10.1037/0033-3204.37.4.370
 31. Lee A, Iskandar A. Social desirability and its effect on help-seeking: Mediated by shame. *JAYPS*. 2025;6(5):11. doi: 10.61838/kman.jayps.6.5.11
 32. Semeleva EV, Pligina YV. Mental health of the Russian population. *Mezhdunarodnyy Nauchno-Issledovatel'skiy Zhurnal*. 2025;(1(151)):91. (In Russ.) doi: 10.60797/IRJ.2025.151.99
 33. Pyzhova OV, Chasovskikh EE. The problem of stigmatization of mental disorders in Russia. *Innova*. 2024;10(1):47-50. (In Russ.)
 34. Leslie-Miller CJ, Joormann J, Quinn ME. Coping flexibility: Match between coping strategy and perceived stressor controllability predicts depressed mood. *Affect Sci*. 2024;6(1):94-103. doi: 10.1007/s42761-024-00275-9
 35. Benuto LT, Casas J, Gonzalez F, Newlands R. The behavioral model of health: Education, behavioral health factors, and stigma as predictors of help-seeking attitudes. *Community Ment Health J*. 2020;56(7):1275-1283. doi: 10.1007/s10597-020-00601-y
 36. Huque R, Azad AK, Islam K, Ahmed HU, Amin MR. Mental health care seeking behavior in Bangladesh: Determinants and treatment gaps. *BMC Psychiatry*. 2025;25(1):779. doi: 10.1186/s12888-025-06813-4
 37. Walter H, Craig ME, Ali M, Faruque S, Saha S. Seeking support: Insights into women's mental health help-seeking behavior in Bangladesh. *Front Glob Womens Health*. 2025;6:1679141. doi: 10.3389/fgwh.2025.1679141
 38. Parra-Mujica F, Johnson E, Reed H, Cookson R, Johnson M. Understanding the relationship between income and mental health among 16- to 24-year-olds: Analysis of 10 waves (2009–2020) of Understanding Society to enable modelling of income interventions. *PLoS One*. 2023;18(2):e0279845. doi: 10.1371/journal.pone.0279845

Сведения об авторах:

Судьин Сергей Александрович – д-р социол. наук, профессор, старший научный сотрудник кафедры социологии; e-mail: sudjin@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3625-6804>.

Носкова Татьяна Вадимовна – младший научный сотрудник кафедры социологии; e-mail: tanitanoskova@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5170-208X>.

✉ **Бург** Анастасия Олеговна – канд. социол. наук., научный сотрудник кафедры социологии; e-mail: an-bg@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2901-3932>.

Информация о вкладе авторов: концепция и дизайн исследования: Судьин С.А.; анализ данных и обзор литературы: Носкова Т.В.; сбор данных и интерпретация результатов: Бург А.О. Все авторы рассмотрели результаты и одобрили окончательный вариант рукописи.

Соблюдение этических стандартов: Исследование выполнено с соблюдением этических норм ICC/ESOMAR, ISA и Российского общества социологов. Участие респондентов было добровольным и анонимным. На качественном этапе исследования перед началом каждого интервью было получено информированное добровольное согласие респондентов в письменной форме, включая разрешение на аудиофиксацию и последующую обработку предоставленных данных в обезличенном виде. На количественном этапе перед началом прохождения опроса все респонденты ознакомились с информацией о целях исследования и дали цифровое информированное согласие (путем проставления галочки в соответствующее поле), что приравнивается к письменному согласию в рамках онлайн-формата.

Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00480-П, <https://rscf.ru/project/23-18-00480-П/>.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.

Статья получена: 23.07.26 / Принята к публикации: 07.09.26 / Опубликовано: 30.09.26

Author information:

Sergei A. Sudin, Dr. Sci. (Soc.), Prof.; Senior Researcher, Department of Sociology; e-mail: sudjin@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3625-6804>.

Tatyana V. Noskova, Junior Researcher, Department of Sociology; e-mail: tanitanoskova@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5170-208X>.

✉ Anastasiya O. Burg, Cand. Sci. (Soc.), Researcher, Department of Sociology; e-mail: an-bg@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2901-3932>.

Author contributions: study conception and design: Sudin S.A.; data analysis, bibliography compilation and referencing: Noskova T.V.; data collection and interpretation of results: Burg A.O. All authors reviewed the results and approved the final version of the manuscript.

Compliance with ethical standards: The study was conducted in compliance with the ethical standards of ICC/ESOMAR, ISA, and the Russian Society of Sociologists. Respondent participation was voluntary and anonymous. During the qualitative phase of the study, written informed consent was obtained before each interview, including permission to audio record and subsequently process the provided data in anonymized form. Before the quantitative phase of the survey, all respondents were informed about the objectives of the study and provided electronic informed consent (by checking the applicable box), which is equivalent to written informed consent.

Funding: The study was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 23-18-00480-П, <https://rscf.ru/project/23-18-00480-П/>.

Conflict of interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Received: July 23, 2026 / Accepted: September 7, 2026 / Published: September 30, 2026